

TEMA 2.7 • GINECOLOGÍA

Leucorrea

PERFIL EUNACOM 2.01.1.072

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Leucorrea

Comparación de las 3 Causas Principales

TABLA 2.7.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS			
	VAGINOSIS BACTERIANA	CANDIDIASIS	TRICOMONIASIS
Agente	<i>Gardnerella vaginalis</i> (anaerobio)	<i>Candida albicans</i> (hongo)	<i>Trichomonas vaginalis</i> (protozoo)
¿ETS?	No	No	Sí
Leucorrea	Blanca/blanco-grisácea	Blanca grumosa (leche cortada)	Amarillo-verdosa, espumosa
Olor	Pescado podrido (aumenta con KOH, menstruación)	Sin olor	Mal olor (no a pescado)
Inflamación	No (sin prurito, sin disuria)	Prurito vaginal intenso (sin inflamación marcada)	Marcada (cuello "en fresa", disuria, prurito)
pH vaginal	> 4.5 (muy alcalino)	< 4 (ácido, normal)	> 4, algo alcalino
Microscopía	Clue cells (células pistas)	Levaduras + hifas	Protozoos flagelados
Tratar pareja	No (salvo síntomas)	No (salvo recurrencia o balanitis)	Sí siempre (ETS)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla rápida: - Sin inflamación + olor a pescado = **Vaginosis** - Blanca grumosa + picazón = **Candidiasis** - Verde/amarilla + cuello en fresa + disuria + ETS = **Tricomoniasis**

1. Vaginosis Bacteriana

- **Diagnóstico:**
- Clínico + Test de KOH (aminas): el olor a pescado **se intensifica** al agregar KOH
- pH > 4.5
- Microscopía: **clue cells** (células epiteliales cubiertas de bacterias)
- **Tratamiento:**
- **Metronidazol 500 mg c/12h x 7 días** (o 250 mg c/8h x 7 días)
- Alternativa: **Clindamicina** óvulos tópicos (si alergia o contraindicación oral)
- No tratar a la pareja (salvo síntomas)

NOTA CLÍNICA

El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis.

2. Candidiasis Vulvovaginal

- **Diagnóstico:**
- Clínico: leucorrea blanca grumosa + prurito intenso
- pH < 4 (ácido, sin cambios)
- Microscopía: levaduras con hifas (pseudohifas)
- **Tratamiento:**

- **Fluconazol 150 mg x 1 dosis** (VO)
- Si embarazada o hepatopatía: **Clotrimazol** óvulos tópicos
- Tratar pareja: solo si hay balanitis o candidiasis recurrente (desde la 2ª recurrencia)

3. Tricomoniasis

- **Diagnóstico:**
- Clínica: leucorrea amarillo-verdosa espumosa + disuria + cuello "en fresa" (punteado rojo)
- pH > 4 (algo alcalino)
- Microscopía: protozoos flagelados móviles
- **Tratamiento:**
- **Metronidazol 2 g x 1 dosis** (monodosis)
- Alternativa: Tinidazol 2 g x 1 dosis
- Si embarazada/hepatopatía: Metronidazol tópico
- **Tratar pareja sí o sí** (ETS — aunque esté asintomática, es reservorio)
- Manejo completo ETS: educación, preservativo, estudios de otras ETS (VIH, VDRL)

4. Otras Causas de Leucorrea

TABLA 2.7.2: CAUSA VS CLÍNICA CLAVE		
CAUSA	CLÍNICA CLAVE	AGENTE
Cervicitis	Vagina normal, flujo saliendo por OCE	Gonorrea, Chlamydia
PIP	Fiebre + dolor pélvico + flujo por OCE	Gonorrea, Chlamydia
Cuerpo extraño	Niñas, leucorrea fétida → puede progresar a metrorragia	Flora anaerobia mixta
Cáncer	Leucorrea + sangrado + masa palpable	—

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No tratar leucorrea "a ciegas" con fluconazol + metronidazol sin examinar. Existen causas graves (cervicitis, PIP, cáncer). Siempre hacer especuloscopia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Leucorrea: Prurito vaginal intenso (sin inflamación marcada) | Marcada (cuello "en fresa", ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Leucorrea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Comparación de las 3 Causas Principales
- 1. Vaginosis Bacteriana
- 2. Candidiasis Vulvovaginal
- 3. Tricomoniasis
- 4. Otras Causas de Leucorrea
- | | Leucorrea | Blanca/blanco-grisácea |
- , espumosa | | Olor |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LEUCORREA)

PREGUNTA 1

En relación a Leucorrea: Prurito vaginal intenso (sin inflamación marcada) | Marcada (cuello "en fresa", ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Leucorrea se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Leucorrea debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Leucorrea requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Leucorrea es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Leucorrea no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Leucorrea?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Leucorrea. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: LEUCORREA

:::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis. :::
:::warning No tratar leucorrea "a ciegas" con fluconazol + metronidazol sin examinar. Existen causas graves (cervicitis, PIP, cáncer). Siempre hacer especuloscopia. :::